Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95080-155 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005076-54.2025.8.21.0010/RS

AUTOR: GABRIELA BORTOLUZ

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

GABRIELA BORTOLUZ ajuizou ação de obrigação de fazer contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.**, partes qualificadas na lide.

Narrou ser beneficiária de plano de saúde mantido pela ré e que foi diagnosticada com Lipedema (CID EF02.2) em membros inferiores e Insuficiência Venosa Crônica Periférica (CID 187.2), com histórico de safenectomia em membro inferior direito. Sustentou que, em razão de suas patologias crônicas, necessita de tratamento contínuo para evitar o agravamento de seu quadro clínico e para manter uma qualidade de vida digna. Afirmou que, entre as terapias indicadas por sua equipe médica, o tratamento de Drenagem Linfática regular se afigura essencial. Contudo, ao solicitar a cobertura para o referido procedimento, teve seu pedido negado pela operadora de saúde em 24 de abril de 2024, sob a justificativa de que o tratamento não constaria do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defendeu a abusividade da negativa, argumentando que o rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa e que a recusa de cobertura atenta contra os seus direitos fundamentais à saúde e à vida, bem como contra as normas do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização e custeio do tratamento de Drenagem Linfática, com a fixação de multa diária por descumprimento e, subsidiariamente, o bloqueio de valores para custeio do tratamento em caráter particular, estimado em R$1.440,00 para um período de três meses. Ao final, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação da ré de custear o tratamento enquanto perdurar a necessidade clínica, com a condenação da demandada aos ônus sucumbenciais. Postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Atribuiu à causa o valor de R$1.440,00. Juntou documentos - Evento 1.

Concedido o benefício de assistência judiciária gratuita à parte autora, sendo, porém, indeferida a tutela de urgência - Evento 15.

Citada, a ré apresentou contestação -Evento 22. Sustentou, em síntese, que o contrato de plano de saúde firmado com a autora é anterior à vigência da Lei nº9.656/98, tratando-se, portanto, de um plano não regulamentado. Alegou que, por essa razão, a relação contratual rege-se estritamente pelas cláusulas pactuadas, as quais não preveem a cobertura para o procedimento de drenagem linfática, havendo, inclusive, cláusula de exclusão para procedimentos com finalidade estética ou não previstos expressamente. Afirmou ter oportunizado à autora, em diversas ocasiões, a adaptação de seu contrato para as novas regras estabelecidas pela Lei dos Planos de Saúde, o que foi por ela recusado. Argumentou, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº1.931, pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98 a contratos celebrados antes de sua vigência. Defendeu a legalidade da negativa de cobertura, por se tratar de exercício regular de um direito, e impugnou a pretensão de inversão do ônus da prova. Juntou documentos, incluindo cópia do contrato, parecer técnico e atos constitutivos. Requereu a improcedência da demanda. Juntou documentos

Seguiu réplica - Evento 25.

Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Invertido o ônus da prova - Evento 28.

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

Relatei. Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o deslinde da causa já se encontram suficientemente demonstrados pelos documentos carreados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor:

> **Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.**

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda

que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a autora é beneficiária de um plano de saúde individual/familiar contratado em 01 de junho de 1996 -evento 22, CONTR2, portanto, em data anterior à promulgação da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Este fato é de suma importância para o deslinde da controvérsia, pois define o regime jurídico aplicável à relação contratual.

Assim, em se tratando de plano de saúde não regulamentado ou adaptado à Lei nº 9.656/98, devem ser respeitadas as cláusulas contratuais estipuladas.

Nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. RESSONÂNICIA MAGNÉTICA. *CONTRATO NÃO REGULAMENTADO*. **INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.** COBERTURA DEVIDA. 1. AINDA QUE INAPLICÁVEL A LEI 9.656/98 AOS *CONTRATOS* DE *PLANO* DE *SAÚDE* FIRMADOS EM DATA ANTERIOR, A QUESTÃO DEVE SER APRECIADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ), COM INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES CONFORME (ART. 47 DO CDC). 2. O *PLANO* DE *SAÚDE NÃO* PODE SE RECUSAR A CUSTEAR O EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR A NECESSIDADE. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO *CONTRATO* PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. 3. NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO CDC, MOSTRA-SE ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DO TRATAMENTO O FÁRMACO PLEITEADO, UMA VEZ QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA FRENTE À OPERADORA DE *PLANO* DE *SAÚDE*. 4. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 381, DO STJ. EXIGIR PEDIDO EXPRESSO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, PORTANTO, NULA DE PLENO DIREITO, VIOLA O ARTIGO 6º, IV DO CDC, QUE ESTABELECEU COMO DIREITO BÁSICO/MÍNIMO DO CONSUMIDOR A PROTEÇÃO CONTRA QUALQUER TIPO DE ABUSO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. POR OUTRO LADO, AS NORMAS DA LEI CONSUMERISTA SÃO DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL, OU SEJA, SÃO DIREITOS QUE ULTRAPASSAM A *INDIVIDUALIDADE* DO SUJEITO. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSIDERANDO QUE FOI DADO A CAUSA O VALOR DE ALÇADA, PLENAMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, §8°, DO CPC. HONORÁRIOS DO PROFISSIONAL QUE DEVEM REMUNERAR COM DIGNIDADE O LABOR. VERBA HONORÁRIA MANTIDA NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50082129620208210022, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-06-2021). [Grifei].

A controvérsia central da presente demanda reside em verificar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento de Drenagem Linfática prescrito à autora, portadora de Lipedema e Insuficiência Venosa Crônica Periférica, frente a um contrato de plano de saúde celebrado em data anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, ou seja, um contrato não regulamentado.

Os contratos de planos de saúde celebrados antes da vigência da referida lei são classificados como "não regulamentados", e suas coberturas e exclusões são regidas, primordialmente, pelas cláusulas pactuadas entre as partes, observados os princípios gerais do direito contratual e as normas de proteção ao consumidor. A aplicação da Lei nº 9.656/98 a tais contratos não é automática, dependendo da expressa opção do consumidor pela adaptação do seu plano, conforme disposto no artigo 35 do referido diploma legal.

No caso concreto, a ré demonstrou ter ofertado à autora a possibilidade de adaptação do seu contrato ao novo regime legal, o que, contudo, foi por ela recusado - evento 22, ANEXO5, fl.7. Ao optar por manter as condições originais da avença, a autora, de forma consciente e voluntária, escolheu permanecer sob a égide do regime contratual original, com suas respectivas coberturas e limitações, presumivelmente em troca de uma contraprestação pecuniária mensal inferior àquela que seria devida em um plano adaptado. Destarte, não pode, agora, pretender valer-se das coberturas e garantias da lei que optou por não aderir, buscando extrair do contrato apenas os bônus, sem arcar com os ônus correspondentes.

A pretensão autoral, portanto, deve ser analisada estritamente sob a ótica do que foi contratado. O ônus da prova, embora invertido por este Juízo na decisão saneadora, não exime a parte autora de apresentar o mínimo de substrato probatório de seu direito. No caso, a ré se desincumbiu de seu ônus ao apresentar o contrato e demonstrar, por meio de seu parecer técnico, que o procedimento postulado não encontra cobertura na apólice da autora.

Constou no comprovante de negativa emitido pela ré -evento 22, ANEXO3:

Prezado cliente,

Informamos que o procedimento **DRENAGEM LINFATICA**, não consta contemplado no Rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Lembramos, inicialmente, que as coberturas assistenciais asseguradas pelo seu plano de saúde, nos termos do art. 10, § 4°, da Lei Federal n°. 9.656/1998, do art. 4°, inc. III, da Lei Federal n°. 9.961/2000, e da Resolução Normativa (RN) n°. 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como regra, limitam-se aos serviços previstos no rol de procedimentos obrigatórios veiculado na referida norma da agência reguladora, admitida, apenas em situações excepcionais, a cobertura para demais tratamentos, contanto que haja comprovação de eficácia com base em evidências científicas irrefutáveis e/ou demonstração de recomendação favorável por parte de órgãos de avaliação de tecnologia em saúde e desde que não incidam nas demais excludentes legais/normativas, o que não é o caso.
Essas circunstâncias, aliadas à ausência de comprovação científica de eficácia e/ou de recomendação de qualquer órgão de avaliação de tecnologia em saúde que corrobore os **DRENAGEM LINFATICA**, prescritos para situações como a sua - ônus que compete ao médico assistente e do qual não se desincumbiu - situam, os referidos exames, à margem da cobertura obrigatória.

Caso não tenha ficado satisfeito com o retorno dessa solicitação e desejar reanálise como última instância da operadora, entre em contato com a Ouvidoria, em até 48 (quarenta e oito) horas úteis, após o primeiro retorno da negativa, através dos seguintes canais de atendimento:

Parecer -evento 22, PARECER4:

Embasamento Técnico

A drenagem linfática está contemplada pelo Rol da ANS no item "REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DO SISTEMA LINFÁTICO E/OU VASCULAR PERIFÉRICO", é obrigatoriamente coberta, nos planos regulamentados pela Lei nº 9.656/1998, quando indicada para o tratamento de condições que prejudiquem a circulação linfática, causadas por diversas doenças ou consequência das mesmas, o que não se enquadra no caso em questão, que se trata de lipedema e pós operatório de varicectomia por insuficiência venosa crônica.
O lipedema é uma condição caracterizada pelo acúmulo desproporcional de tecido adiposo subcutâneo, frequentemente confundido com linfedema ou obesidade, mas com etiologia distinta. Estudos indicam que, embora o lipedema esteja associado à dilatação dos vasos linfáticos, não há disfunção linfática significativa nos estágios iniciais da doença. Além disso, não foram observadas alterações morfológicas significativas nos vasos linfáticos em pacientes com lipedema, apesar dos níveis elevados de VEGF-C e infiltração de macrófagos.
No que diz respeito à função venosa e linfática no lipedema, um estudo demonstrou que a maioria dos pacientes apresenta apenas pequenas anormalidades na função venosa e linfática, sem atingir os níveis de comprometimento observados no linfedema verdadeiro. Isso sugere que o lipedema é melhor classificado como uma lipodistrofia, em vez de uma consequência direta de insuficiência venosa ou linfática primária.
Para o tratamento do linfedema, que pode ser uma condição associada ou evolutiva em casos de lipedema, a drenagem linfática manual é uma das opções terapêuticas que, quando combinada com outras terapias, pode reduzir o volume dos membros. No entanto, a eficácia da drenagem linfática especificamente para lipedema ainda não está bem estabelecida na literatura.
Em relação à insuficiência venosa, as diretrizes para o manejo de úlceras venosas sugerem que a drenagem linfática pode ser um tratamento adjunto útil em alguns casos de edema venolinfático resistente, embora a evidência formal de suporte seja limitada.
Portanto, enquanto a drenagem linfática é uma prática comum no manejo de condições linfáticas, sua aplicação específica em lipedema e insuficiência venosa crônica requer mais investigação para estabelecer sua eficácia e papel terapêutico. Dessa forma não há respaldo técnico e cobertura no rol da ans para realização de drenagem linfática no quadro clínico em questão.

O contrato em questão, em seu Capítulo Quinto, elenca os serviços não cobertos, sendo que na alínea 'e', está expressamente excluído o tratamento para obesidade para fins estéticos ou qualquer procedimento com finalidade estética.

e - **Cirurgia plástica embelezadora, cirurgia plástica recuperadora para tratamentos de seqüelas existentes antes da assinatura do contrato, mamoplastia redutora, tratamento para obesidade para fins estéticos, ou qualquer outro prodedimento médico com finalidade estética.**

Ademais, o laudo que médico do angeologista apresentado pela autora sugeriu que: "convém avaliar o sintoma e o repouso, além do tratamento com dieta, drenagem linfática e uso de (...)" -evento 1, LAUDO5.

Ou seja, não há um laudo demonstrando a necessidade do tratamento, apenas sugerindo a avaliação do tratamento de drenagem linfática, porém, sequer há indicação da periodicidade das sessões.

A alegação da autora de que o rol de procedimentos da ANS teria natureza exemplificativa, ainda que correta em determinadas situações para contratos regulamentados, não se aplica ao presente caso. A obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos listados pela ANS advém diretamente da Lei nº 9.656/98, à qual o contrato da autora não está submetido por sua própria opção. Portanto, a discussão sobre a taxatividade ou exemplificatividade do referido rol se torna inócua, uma vez que a fonte da obrigação, no caso dos autos, é o contrato, e não a regulamentação da agência reguladora.

Ademais, e apenas a título de reforço argumentativo, ainda que se considerasse a aplicação subsidiária das normas da ANS, o parecer técnico juntado pela ré esclarece de forma fundamentada que, mesmo no âmbito dos planos regulamentados, a cobertura para "Drenagem Linfática" está prevista na Diretriz de Utilização (DUT) do procedimento "REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DO SISTEMA LINFÁTICO E/OU VASCULAR PERIFÉRICO", sendo indicada para condições que afetem a circulação linfática, o que, segundo o parecerista, não seria o caso do lipedema em seus estágios iniciais, o qual se classifica como uma lipodistrofia. Assim, mesmo sob a ótica da regulamentação da ANS, a cobertura para a patologia específica da autora seria questionável.

É certo que o direito à saúde é garantia constitucional e a dignidade da pessoa humana é um dos pilares. Contudo, a assistência à saúde suplementar é exercida em caráter complementar ao sistema público, por meio de relações contratuais de natureza privada. A imposição de coberturas não previstas em contrato, especialmente em planos não regulamentados onde o consumidor optou por manter condições mais restritivas, implicaria em desequilíbrio atuarial para a operadora e para a coletividade de beneficiários, que teriam de arcar com o aumento dos custos.

Dessa forma, a negativa de cobertura por parte da ré, ao se basear na exclusão contratual em um plano de saúde não regulamentado ou ausência de previsão no rol da ANS, para o caso específico, configura exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou abusividade. A pretensão da autora, de obter a restituição dos valores despendidos com o tratamento particular e de compelir a ré a custear futuras sessões, não encontra amparo no contrato firmado entre as partes.

Portanto, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Isso posto, **JULGO IMPROCEDENTE** a presente ação proposta por **GABRIELA BORTOLUZ** contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento da taxa única e despesas processuais, bem como honorários ao procurador da parte ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, dada a simplicidade da ação, sem dilação instrutória. Exegese do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em relação à parte autora, na forma do art.98, §3º, do CPC, em razão de estar litigando sob o manto da gratuidade da justiça.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Intimações agendadas no sistema.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 07/08/2025, às 15:03:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10087876262v14** e o código CRC **862b091b**.